CAPÍTULO 4

Estrutura, aplicação e interpretação do Fonar

Após compreender os conceitos fundamentais da violência doméstica e familiar contra a mulher, os fatores de risco e de proteção e os critérios de classificação dos níveis de perigo, esta seção apresenta o **Fonar como instrumento técnico central para a gestão qualificada desses riscos**. O formulário foi concebido para apoiar a tomada de decisões nos diferentes pontos da rede, garantindo que sinais de agravamento sejam identificados com rapidez e que medidas protetivas de urgência, medidas cautelares e encaminhamentos para a rede sejam adotados de forma tempestiva e proporcional à gravidade do caso.

A correta utilização do Fonar exige que profissionais conheçam sua finalidade estratégica, sua estrutura dividida em partes complementarmente articuladas, as orientações de preenchimento e os cuidados necessários para um registro preciso e seguro das informações. Além de identificar eventos já ocorridos, o instrumento permite avaliar indicadores preditivos de risco futuro e contextualizar a situação de violência a partir de elementos como histórico de agressões, comportamento do(a) agressor(a), marcadores interseccionais e vulnerabilidades sociais, dentre outros.

Importante destacar que a aplicação do Fonar deve seguir **princípios éticos e de proteção integral**, bem como os **princípios de precaução e da proibição de proteção deficiente**, assegurando o **respeito à dignidade, à autonomia e à privacidade da mulher**. É fundamental que o(a) profissional conduza o preenchimento em espaço adequado, com **sensibilidade, empatia e compromisso com o sigilo das informações**, evitando qualquer prática que possa gerar constrangimento, pressão ou revitimização. O processo de registro deve valorizar o tempo e o estado emocional da vítima, priorizando a escuta atenta e o acolhimento seguro.

ATENÇÃO:
O que fazer em caso de recusa da vítima em responder o Fonar?

É necessário que haja orientação clara em situações de eventual recusa da vítima em responder ao formulário. A mulher deve ser informada, em linguagem simples e acessível, sobre a finalidade do Fonar, a importância do seu preenchimento para a avaliação de risco e quais instituições da rede terão acesso às informações registradas. **Recomenda-se que, em caso de recusa pela vítima, seja realizado posterior encaminhamento para equipe multiprofissional (como atendimento psicossocial) para acolhimento**.

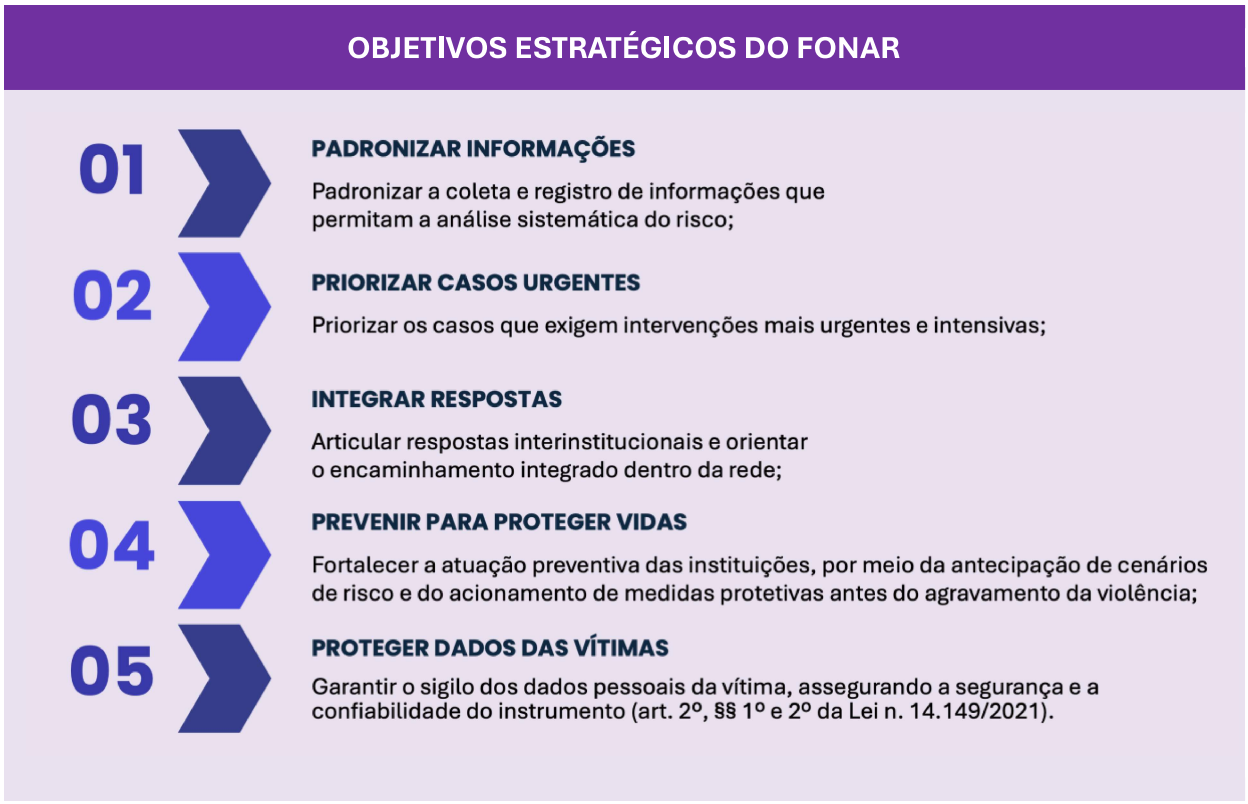
Caso decida não prosseguir com o preenchimento, essa recusa deverá ser registrada formalmente no sistema. O Fonar eletrônico na PDPJ-Br e no Portal Jus.Br dispõe, para esse fim, do botão "Recusa da vítima", que permite documentar a decisão, assegurando a rastreabilidade do ato, sem prejuízo da adoção de outras medidas de proteção cabíveis. Da mesma forma, na versão impressa (Anexo I deste Guia), a recusa pode ser assinalada pelo(a) profissional na seção destinada ao registro das condições do atendimento, garantindo a formalização do ato e o respeito à autonomia da vítima.

As seções a seguir detalham como aplicar, interpretar e utilizar o Fonar para subsidiar a análise técnica, as decisões protetivas e o encaminhamento adequado do caso nas redes de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo que a avaliação realizada cumpra seu propósito essencial: evitar novos episódios de violência e prevenir o feminicídio.

4.1 FINALIDADE E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO INSTRUMENTO

De acordo com a Resolução Conjunta CNJ/CNMP n. 5/2020 e a Lei n. 14.149/2021, o Fonar foi criado como instrumento técnico-operacional no âmbito das políticas públicas de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O seu objetivo principal é identificar os fatores que indicam o risco de a mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas e familiares, para subsidiar a atuação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e demais entidades das redes de atendimento e de enfrentamento na gestão desse risco (art. 2º, par. 1º da Lei n. 14.149/2021 e art. 2º da Resolução Conjunta CNJ/CNMP n. 5/2020).



Desse modo, o Fonar assume papel central na mudança de paradigma, de gestão ativa e preventiva dos riscos, alinhada à devida diligência estatal e à proteção integral da mulher em situação de violência.

4.2 ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA APLICAÇÃO DO FONAR

A aplicação do Fonar deve ocorrer de forma qualificada e alinhada às normas vigentes, garantindo padronização nacional, compartilhamento seguro das informações e atuação coordenada das redes de atendimento e de enfrentamento.

ESTRUTURA DO FONAR	
PARTE I Questões Objetivas	▪ Informações processuais, cadastrais e diferença de idade ▪ Vínculo entre as partes ▪ Histórico de violência ▪ Sobre o(a) agressor(a) ▪ Sobre a vítima ▪ Outras informações importantes
PARTE II Avaliação Semiestruturada Complementar	▪ Informações processuais e cadastrais ▪ Percepção do risco pela vítima ▪ Contexto atual de risco e novas violências ▪ Saúde física, mental e emocional da vítima ▪ Histórico de violência e sobre o(a) agressor(a) ▪ Outros fatores de risco ▪ Fatores de proteção verificados ▪ Orientações, encaminhamentos e outras medidas ▪ Interesse da vítima nos encaminhamentos realizados

4.2.1 Quem pode aplicar?

O Fonar pode ser aplicado por diferentes instituições que compõem o sistema de Justiça, o Sistema Único de Segurança Pública, a assistência social e a saúde, com diferentes níveis de responsabilidade, conforme art. 2º, par. 1º da Lei n. 14.149/2021 e art. 2º da Resolução Conjunta CNJ/CNMP n. 5/2020.

- **Preferencialmente:** Polícia Civil, no momento do registro da ocorrência policial;
- **Subsidiariamente:** Ministério Público e Poder Judiciário, durante o primeiro atendimento ou análise do caso;
- **Facultativamente:** Outros órgãos e entidades públicas ou privadas que atuem na área de prevenção e de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, como Defensorias Públicas, advocacia, Polícia Militar, Centros de Referência de Atendimento à Mulher (Crams), unidades da assistência social (Cras e Creas), serviços de saúde, conforme suas atribuições institucionais e observados os fluxos de gestão do risco estabelecidos no território. O mapeamento dos órgãos das redes de atendimento e de enfrentamento e as estratégias de atuação com o Fonar estão detalhados na Seção 5.1 deste Guia.

A vítima pode realizar o autopreenchimento somente da *Parte I – Questões objetivas*, podendo receber apoio para compreensão das perguntas, quando necessário. Já a *Parte II – Avaliação semiestruturada complementar*, deve ser realizada por profissional

capacitado(a), com experiência em técnicas de entrevista e conhecimento sobre fatores psicossociais, funcionamento global e saúde mental, a fim de garantir uma análise qualificada do risco identificado.

4.2.2 Quando aplicar?

O Fonar deve ser aplicado a todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de requerimento de medida protetiva de urgência. O formulário deve ser aplicado:

- Preferencialmente no **primeiro atendimento**, especialmente em delegacias de polícia, para orientar medidas de proteção imediatas e específicas ao caso;
- Sempre que houver **novo fato relevante ou sinais de agravamento** da violência;
- Durante **acompanhamento continuado** do caso, para verificar aumento, redução ou manutenção do risco.

Importante reconhecer que a **Parte I e a Parte II são etapas distintas, autônomas e complementares do processo de avaliação de risco**, cada uma com objetivos e momentos próprios de aplicação. A Parte I realiza o levantamento inicial das informações essenciais para identificar o risco e orientar respostas imediatas, preferencialmente no primeiro atendimento ou no registro da ocorrência. Já a Parte II deve ser utilizada em atendimentos subsequentes ou quando houver necessidade de aprofundar a análise, permitindo qualificar a avaliação inicial a partir da escuta qualificada e da compreensão do contexto psicossocial da vítima.

Caso a Delegacia de Polícia – porta usual para o primeiro preenchimento do Fonar – conte com profissional qualificado(a) em avaliação psicossocial, recomenda-se a realização também da Parte II. Na ausência desse(a) profissional, deve-se proceder ao preenchimento da Parte I e, quando cabível, encaminhar imediatamente o requerimento de medida protetiva de urgência. Do mesmo modo, nas Casas da Mulher Brasileira, onde atuam, em um mesmo espaço, delegacias e centros de referência com serviços psicossociais, recomenda-se a criação de fluxos integrados que possibilitem o preenchimento das Partes I e II.

Ou seja, a **Parte II não é requisito obrigatório para a conclusão da avaliação de risco inicial**, destinada à adoção das providências iniciais de assistência e de proteção, como a atuação imediata das instituições de segurança pública ou a concessão de medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário. Portanto, sua **aplicação deve ser pautada pela qualificação técnica dos(as) integrantes da rede de atendimento, considerando a evolução do caso e os fluxos adotados no território**. Essa distinção

funcional entre as duas etapas torna possível monitorar a permanência, redução ou agravamento do risco ao longo do atendimento, avaliando a manutenção e ampliando a precisão das medidas de proteção e subsidiando decisões mais informadas e tempestivas pela rede.

4.2.3 Onde acessar a versão eletrônica?

O Fonar eletrônico está disponível no link https://fonar.pdpj.jus.br. Para acessar, é necessário realizar login seguro por meio de:

- SSO (*single sign-on*) da PDPJ-Br, para magistrados(as) e servidores(as) do Judiciário; ou
- Conta gov.br, para agentes externos das redes de atendimento e de enfrentamento, a partir de cadastro e autorização prévias.

Recomenda-se consultar o *Manual do(a) Usuário(a) do Fonar* eletrônico para orientações detalhadas sobre o sistema, tais como:

- Como realizar o login conforme o perfil de acesso;
- Como criar, retomar, submeter e fazer download de formulários;
- Como consultar formulários já submetidos no sistema, por meio de consulta nacional pelo CPF ou Passaporte da vítima;
- Como gerar link seguro para autoaplicação da vítima da Parte I, para preenchimento remoto, como via celular, por exemplo.

Em caso de indisponibilidade tecnológica ou de documentos da vítima, falha de acesso ou situação emergencial, o instrumento pode ser preenchido manualmente por meio da versão impressa, disponível no Anexo I deste Guia.

4.3 ESTRUTURA DO FORMULÁRIO

A estrutura do Fonar foi organizada em duas partes complementares, que se articulam para uma análise ampla, precisa e dinâmica do risco. A Parte I reúne questões objetivas voltadas à identificação inicial e padronizada dos principais fatores de risco, permitindo uma leitura imediata da gravidade da situação e subsidiando a adoção célere de medidas protetivas. Já a Parte II, de natureza semiestruturada, possibilita aprofundar aspectos do contexto de vida da mulher, sua percepção de risco, a evolução do caso ao longo do tempo, e a presença de fatores de proteção.

Ademais, o design do formulário – tanto na versão impressa para preenchimento manual, quanto na versão eletrônica disponível na PDPJ-Br e no Portal Jus.Br – organiza as opções de resposta de modo que, **à esquerda**, se concentram as alternativas que indicam **presença de fatores de risco**, enquanto, **à direita**, ficam as respostas que indicam **ausência desses fatores** (ver figura a seguir). Essa disposição visual facilita a interpretação dos resultados e a identificação do nível de risco.

EXEMPLO TELA FONAR ELETRÔNICO – PDPJ-Br e Portal Jus.Br



Além disso, as perguntas marcadas com asterisco vermelho (*) são de preenchimento obrigatório, por integrarem o núcleo mínimo de informações essenciais à adequada avaliação e classificação do risco. A seguir, cada pergunta do formulário será detalhada com orientações práticas de interpretação e encaminhamento, visando qualificar a tomada de decisões pelos órgãos da rede.

4.3.1 Parte I – Questões Objetivas

FORMULÁRIO COMENTADO



INFORMAÇÕES PROCESSUAIS, CADASTRAIS E DIFERENÇA DE IDADE

As informações processuais e cadastrais do Fonar permitem contextualizar o atendimento e qualificar a avaliação inicial do risco. Esses campos incluem identificação da vítima e do(a) agressor(a), com destaque para a possibilidade de registro do **nome social**, assegurando respeito à identidade de gênero da pessoa atendida; a **idade**, utilizada para o cálculo da diferença etária entre as partes – **fator associado ao risco quando igual ou superior a nove anos**; além de **identidade de gênero**, **orientação sexual**, **escolaridade** e **nacionalidade**, que auxiliam na identificação de vulnerabilidades sociais relevantes para a gestão do risco.

Conforme apresentado nas Seções 2.2 e 3.6, as opções de resposta sobre **identidade de gênero** previstas no Fonar:

Para a vítima:
- Mulher cis;
- Mulher trans;
- Travesti;
- Pessoa não-binária;
- "Outro", com campo aberto para especificação.

Para a pessoa agressora:
- Homem cis;
- Mulher cis;
- Homem trans;
- Pessoa transmasculina;
- Mulher trans;
- Travesti;
- Pessoa não-binária;
- "Outro", com campo aberto para especificação.

Essa estrutura respeita o entendimento normativo e jurisprudencial de que o Fonar deve ser aplicado em situações de violência doméstica e familiar praticadas contra vítimas com identidade de gênero feminina, independentemente da identidade de gênero (feminina ou masculina) da pessoa agressora.

Do mesmo modo, as opções de resposta sobre **orientação sexual** previstas no Fonar incluem:

Para a vítima:
- Heterossexual;
- Lésbica;
- Bissexual;
- Assexual;
- Pansexual;

Para a pessoa agressora:
- Heterossexual;
- Lésbica;
- Gay;
- Bissexual;
- Assexual;
- Pansexual;

• "Outro", com campo aberto para especificação.	• "Outro", com campo aberto para especificação.

Essa categorização assegura que relações afetivas e sexuais entre mulheres sejam corretamente identificadas no atendimento, reforçando a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em contextos de violência doméstica e familiar envolvendo mulheres lésbicas, bissexuais, dentre outras.

VÍNCULO ENTRE AS PARTES

Essa seção apresenta opções que permitem identificar se a violência ocorre no contexto afetivo, familiar ou de convivência doméstica, em conformidade com o art. 5º da Lei Maria da Penha. As alternativas previstas abrangem:

- **Relacionamento afetivo:** marido/esposo(a), companheiro(a), namorado(a), ex-marido/ex-esposo(a), ex-companheiro(a), ex-namorado(a), além de "outro", com campo aberto para especificação.
- **Relacionamento familiar:** pai, mãe, padrasto, madrasta, irmã(o), filho(a), avô/avó, tio(a), primo(a), cunhado(a), sobrinho(a), enteado(a), genro/nora, com campo aberto para outras configurações familiares.
- **Relacionamento doméstico:** pessoas que residem na mesma casa ou que já tenham residido, como cuidador(a) ou empregado(a) doméstico(a), entre outras possibilidades.

Essas categorias asseguram que o vínculo considerado na avaliação do risco reflita a dinâmica de violência baseada no gênero reconhecida pela Lei Maria da Penha: situações que ocorrem no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relações íntimas de afeto, independentemente de coabitação, orientação sexual ou estado civil.

BLOCO I – SOBRE O HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

1. O(A) agressor(a) já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?

Esta pergunta investiga um dos fatores de risco relevantes para a predição de feminicídio: a presença de ameaças dirigidas à vítima ou a terceiros, sobretudo quando utilizadas como forma de controle e intimidação. Conforme discutido nas Seções 3.2 e 3.3,

ameaças letais, especialmente quando envolvem familiares – como filhos e filhas –, sinalizam potencial de letalidade e podem elevar a classificação para risco grave ou extremo quando associadas a outros comportamentos de escalada da violência e perseguição. Além disso, como destacado na Seção 3.5, ameaças reiteradas indicam persistência da dinâmica abusiva e aumento da probabilidade de agressões físicas severas.



2. O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) das seguintes formas graves de agressão física contra você?

Esta pergunta avalia a ocorrência de agressões físicas graves, com alto valor preditivo para risco extremo e feminicídio, conforme apresentado na Seção 3.2. As opções de resposta incluem, de forma exemplificativa: estrangulamento, golpes com arma de fogo ou arma branca, queimaduras, lesões com objetos contundentes, espancamentos e socos reiterados, entre outras modalidades severas de violência física. Cada uma dessas condutas revela uso intencional de força com potencial de causar lesões graves ou morte, indicando escalada e letalidade no comportamento do(a) agressor(a) (Seções 3.3 e 3.5). Diante de resposta positiva, especialmente quando associada a episódios recentes ou repetidos, recomenda-se priorização imediata do caso, análise célere da classificação do risco e articulação rápida de medidas protetivas e encaminhamentos à rede de atendimento, conforme detalhamento na Seção 5.3.



2.1. O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) destas agressões físicas contra você?

Esta pergunta identifica agressões físicas que não alcançam, por si só, o patamar de risco extremo de feminicídio, mas que representam continuidade do ciclo de violência e indicam risco grave ou moderado, conforme os parâmetros apresentados na Seção 3.3 do Guia. Tais agressões – como tapas, empurrões, chutes, puxões de cabelo ou arremesso de objetos – costumam estar presentes em situações de reiteração e escalada da violência, especialmente quando a frequência aumenta ou quando se combinam com violência psicológica e controle coercitivo (Seções 3.2 e 3.5). Lembre-se de que uma resposta definitiva do grau do risco exige análise do conjunto de fatores identificados no Fonar, considerando o contexto relacional, a temporalidade, o agravamento e reiteração das agressões, além do histórico criminal e de descumprimento de medidas legais pelo(a) agressor(a), para então orientar a melhor estratégia de gestão do risco.



2.2. Você necessitou de atendimento médico e/ou internação após algumas dessas agressões?

Esta pergunta identifica situações em que as agressões físicas possam ter produzido lesões significativas, com potencial de agravamento do risco e de comprometimento da integridade física e psicológica da vítima. Além de contribuir diretamente para a estimativa do risco e para o monitoramento de possíveis sequelas decorrentes da violência, esta pergunta também cumpre função assistencial e protetiva: permite o mapeamento de demandas urgentes de saúde, incluindo avaliação clínica imediata, emissão de laudos que subsidiam decisões protetivas e encaminhamento a serviços especializados, como atendimento psicológico, perícia e acompanhamento continuado pela rede de saúde.



3. O(A) agressor(a) já obrigou você a ter relações sexuais ou praticar atos sexuais contra a sua vontade?

A violência sexual no contexto doméstico é um fator de risco grave e extremo, pois indica alto nível de controle e humilhação, associado à probabilidade de escalada para o feminicídio (Seções 3.2 e 3.3). Diante de resposta positiva e se o fato tiver sido recente, é fundamental acionar imediatamente a rede de saúde para avaliação clínica, profilaxia de IST/HIV, contracepção de emergência e demais cuidados necessários, além do encaminhamento rápido para perícia especializada, com preservação da cadeia de custódia de possíveis vestígios, quando houver. Além disso, a mulher deve ser orientada sobre a possibilidade de registrar a ocorrência para a formalização da denúncia.



4. O(A) agressor(a) já teve algum destes comportamentos?

As opções de resposta investigam ciúmes excessivos, vigilância e monitoramento, restrição de contatos e atividades, controle financeiro, destruição ou subtração de bens, retenção de documentos, entre outras formas de violência patrimonial e psicológica, por meio de controle coercitivo. Nesses casos, a Lei Maria da Penha autoriza medidas protetivas patrimoniais, como a restituição de bens indevidamente subtraídos (art. 24, I). Esses comportamentos revelam dinâmica abusiva persistente e são reconhecidos como fatores de risco para agravamento da violência (Seções 3.2 e 3.5), pois ampliam o poder do(a) agressor(a) sobre a vítima, dificultando a ruptura do relacionamento em curso, ou indicando a dificuldade pelo(a) ofensor(a) de dissociação afetiva em um relacionamento já

findo. É importante considerar que o controle excessivo exercido no período do relacionamento permanece como fator de risco mesmo após o término.



5. Você já registrou ocorrência policial ou solicitou medida protetiva de urgência contra o(a) agressor(a)?
5.1. O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente?

Estas perguntas avaliam o histórico institucional de proteção e sinalizam se a vítima já buscou por apoio do sistema de Justiça. Resposta positiva indica persistência do risco, especialmente quando houve agressões após o registro policial ou descumprimento de medidas protetivas, elemento reconhecido como fator de risco grave ou extremo (Seções 3.2 e 3.3). Nesses casos, o descumprimento de medida protetiva configura crime específico, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, reforçando a necessidade de ação imediata do sistema de Justiça e da segurança pública para contenção do risco e responsabilização do(a) agressor(a).



6. As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) se tornaram mais frequentes e/ou mais graves nos últimos 12 meses?

Esta pergunta verifica a escalada da violência, elemento fortemente associado ao risco grave e extremo (Seções 3.2 e 3.5). O aumento da frequência ou da severidade das agressões indica progressão do risco e aproximação de possíveis desfechos letais, exigindo intervenções imediatas e medidas protetivas proporcionais ao nível de risco identificado, conforme orientações da Seção 5.3.



BLOCO II – SOBRE O(A) AGRESSOR(A)
7. O(A) agressor(a) faz uso abusivo de álcool ou de drogas ou de medicamentos?

Esta pergunta busca identificar condutas que podem potencializar comportamentos violentos, sobretudo quando associadas a ciúme, controle ou histórico de agressões (Seções 3.2 e 3.5). Embora o uso abusivo não seja a causa da violência, pode aumentar a impulsividade, reduzir o controle inibitório e elevar o risco de agressões graves, exigindo atenção ao contexto global do risco e possíveis encaminhamentos do(a) agressor(a) para a rede de atendimento psicossocial e de saúde mental.



8. O(A) agressor(a) tem alguma doença mental comprovada por avaliação médica?

Esta pergunta identifica se há diagnóstico médico formal relacionado a transtorno mental, o que pode influenciar a gestão do risco e os encaminhamentos necessários. Assim como verificado na pergunta anterior, a presença de doença mental não é causa da violência, mas pode potencializar riscos quando associada a outros fatores, como resistência em aderir a tratamento, descompensação clínica, impulsividade, descumprimento de medidas ou uso abusivo de álcool e drogas. Em caso de resposta positiva, é importante avaliar a necessidade de medidas de responsabilização e tratamento, conforme articulação da rede.



9. O(A) agressor(a) já tentou suicídio ou falou em suicidar-se?

Esta pergunta busca identificar comportamento autoagressivo, reconhecido na literatura como indicador de alto risco de feminicídio seguido de suicídio ou de agressões mais violentas quando a mulher tenta romper a relação (Seções 3.2 e 3.5). Além de revelar instabilidade emocional, esse comportamento indica que o(a) agressor(a) pode estar propenso a adotar condutas extremas contra a mulher e, até mesmo, contra seus(suas) dependentes, demonstrando reduzida inibição diante das consequências legais, pois não teria nada a perder. Diante de resposta positiva, é necessário avaliar com atenção o contexto emocional do(a) agressor(a), bem como articular imediatamente ações preventivas e de responsabilização, devido ao potencial de letalidade envolvida.



10. O(A) agressor(a) está desempregado(a) ou tem dificuldades financeiras?

Esta pergunta identifica estresse econômico e instabilidade financeira, fatores que podem agravar o risco quando combinados com ciúme, controle e histórico de agressões. A dependência da mulher com relação ao(a) agressor(a) que está passando por dificuldades financeiras ou desemprego pode intensificar conflitos, impulsividade e tensões no relacionamento. Esse fator também se relaciona ao dispositivo de eficácia (Zanello, 2018), segundo o qual expectativas socioculturais vinculadas ao papel masculino de “provedor” podem levar o agressor a sentir sua masculinidade ou poder ameaçados diante da perda de renda, aumentando a probabilidade de comportamentos violentos.

Entretanto, de forma isolada, esse elemento não configura risco grave, devendo ser interpretado à luz do conjunto de fatores de risco e do contexto da violência identificado no Fonar.



11. O(A) agressor(a) tem fácil acesso a arma de fogo?

O acesso facilitado a arma de fogo – seja por posse própria ou em razão da atividade profissional (como policial civil, militar, penal etc. ou segurança privada) – é um dos fatores de risco mais fortes para feminicídio (Seções 3.2 e 3.3), devendo ser considerado risco grave ou extremo. Nesses casos, a atuação policial deve ser imediata, com verificação de porte ou posse, nos termos do art. 12, VI-A, da Lei Maria da Penha, incluindo consulta a registros e comunicação à instituição responsável quando se tratar de armamento institucional, podendo subsidiar a requisição judicial de busca e apreensão da arma de fogo para proteção da vítima, conforme art. 18, IV, da LMP.



12. O(A) agressor(a) já ameaçou ou agrediu seus(suas) filhos(as), outros familiares, outras parceiras íntimas, amigos(as), colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais de estimação?

Esta pergunta identifica ampliação do círculo da violência, incluindo agressões e ameaças contra filhos(as), familiares, pessoas próximas ou mesmo animais, conduta que expressa alto grau de controle, impulsividade e periculosidade do(a) agressor(a). A crueldade com animais indica tolerância à violência e baixa empatia, além de usualmente funcionar como uma violência vicária contra a mulher. Esses comportamentos são reconhecidos como fatores de risco grave ou extremo (Seções 3.2 e 3.5), pois indicam potencial de violência letal e intenção de atingir a vítima por meio de terceiros, além de demandarem atuação imediata da rede para proteção da mulher e dos(as) dependentes, conforme estratégias apresentadas na Seção 5.3.



12.1. Você tem conhecimento de registro de ocorrência policial e/ou medida protetiva de urgência contra ele/ela por essas violências?

Resposta positiva reforça a persistência e reiteração da violência, além de indicar histórico formalmente reconhecido pelas instituições, o que eleva ainda mais o risco e demanda priorização imediata nas estratégias de proteção.



BLOCO III – SOBRE VOCÊ (VÍTIMA)
13. Você terminou, tentou ou manifestou intenção de terminar com o(a) agressor(a) recentemente?

Esta pergunta identifica situações de ruptura real ou iminente do relacionamento, reconhecidas como um dos principais fatores de risco para feminicídio (Seções 3.2 e 3.5). A iminência ou recenticidade do término pode ser percebida pelo agressor como ameaça direta à sua autoridade, acionando expectativas sociais de afirmação da masculinidade e "crenças de posse" sobre a mulher. Esse quadro frequentemente funciona como gatilho para a intensificação de intimidações, perseguições e punições por meio de formas mais graves de violência. Além disso, a separação recente pode agravar vulnerabilidades da mulher em diferentes dimensões – habitacional, financeira, guarda dos filhos e status migratório – demandando atenção articulada da rede. A análise também permite distinguir situações em que a mulher já tomou medidas concretas para se afastar, mas não conseguiu manter o distanciamento, daquelas em que ela apenas manifestou verbalmente a intenção de terminar, sem ações efetivas de separação. Em ambos os cenários, observa-se aumento significativo do risco de reações violentas por parte do(a) agressor(a), impondo a necessidade de respostas céleres e coordenadas da rede, conforme estratégias apresentadas na Seção 5.3.



14. Você tem filhos?
14.1. Qual a faixa etária de seus filhos?
14.2. Algum de seus filhos é pessoa com deficiência?
14.3. Estão vivendo algum conflito com relação à guarda dos filhos, visitas ou pagamento de pensão pelo(a) agressor(a)?
14.4. Seu(s) filho(s) já presenciaram ato(s) de violência do(a) agressor(a) contra você?

Essas perguntas identificam a existência de filhos e filhas sob responsabilidade da vítima e as condições em que estão inseridos, elementos que podem agravar a vulnerabilidade da mulher, ampliar o controle coercitivo do(a) agressor(a) e indicar risco de violência vicária ou de violência direta contra crianças e adolescentes (Seção 3.7). Quando a mulher possui filhos(as), há usualmente uma sobrecarga nas funções de cuidado sob responsabilidade dela. Muitas mulheres relutam em romper as relações para evitar que seus(suas) filhos(as) percam o contato com o(a) genitor(a).

A presença de filhos(as) com deficiência demanda atenção ainda maior, pois a dependência funcional agrava a sobrecarga nas funções de cuidado pela mulher e pode intensificar o poder de controle do(a) agressor(a), aumentando os riscos envolvidos.

Conflitos relacionados a guarda, visitas ou pagamento de pensão podem ser instrumentalizados pelo(a) agressor(a) como forma de retaliação, especialmente em contextos de ruptura da relação. Se houve separação, o contato forçado e prolongado com o(a) ofensor(a), nos momentos de visitação, podem se tornar gatilhos para a escalada de novos episódios de violência, além do risco de utilização das crianças para seguir vigiando e controlando a mulher. Em outros contextos, a existência de filhos(as) de um relacionamento anterior desencadeia sentimentos de posse – por não se dedicar integralmente ao(à) ofensor(a) e sua prole – que podem evoluir para violências.

Além disso, quando filhos(as) presenciam atos de violência, há impacto direto em seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, conforme detalhado na Seção 2.3 sobre os impactos sociais e psicológicos da violência, ampliando o risco de ciclos intergeracionais de violência. Nessas circunstâncias, a proteção deve abranger toda a família, sendo possível, conforme o art. 22, IV, da Lei Maria da Penha, determinar medidas protetivas como a restrição ou suspensão de visitas ao(à) agressor(a), mediante avaliação técnica de equipe especializada, com o objetivo de salvaguardar a integridade da mulher e de seus(suas) dependentes. Também é importante articular a rede especializada de proteção às crianças e adolescentes disposta no ECA, com especial atuação da assistência social e do sistema de Justiça.



15. Você sofreu algum tipo de violência durante a gravidez ou até 18 meses após o parto?

Esta pergunta identifica situações de violência na gestação e no puerpério, períodos reconhecidos como de risco elevado para agravamento da violência doméstica e familiar, devido ao aumento da vulnerabilidade física, emocional e econômica da mulher (Seções 2.3 e 3.7). Ademais, pode criar sentimentos de posse do(a) agressor(a) à mulher, por dividir a atenção com o(a) bebê. Pesquisa documentou que este é um fator de risco associado a situações de risco extremo, com elevada correlação linear com a presença dos demais fatores de risco (Ávila *et al.*, 2023). A violência nesses momentos também impacta diretamente a saúde e o desenvolvimento do(a) bebê, podendo provocar complicações gestacionais, parto prematuro e prejuízos ao vínculo materno-infantil. Diante de resposta positiva, recomenda-se priorização imediata da proteção e articulação com a rede de saúde para acompanhamento especializado.

16. Se você está em um novo relacionamento, percebeu que as ameaças ou agressões físicas aumentaram em razão disso?

Esta pergunta identifica situações em que o ciúme, o sentimento de posse e a percepção de perda de controle pelo(a) agressor(a) intensificam a violência, elemento associado à escalada do risco e à possibilidade de letalidade (Seções 3.2 e 3.5). Quando o início de um novo relacionamento desencadeia aumento de ameaças ou agressões, reforça-se o caráter retaliatório da violência, demandando atenção imediata e medidas de proteção proporcionais ao agravamento identificado, conforme estratégias dispostas na Seção 5.3.

17. Você se sente isolada de amigos, familiares, pessoas da comunidade ou trabalho?

Esta pergunta avalia situações de isolamento social, estratégia comumente utilizada pelo(a) agressor(a) para reduzir a rede de apoio e dificultar a busca por ajuda (Seções 3.5 e 3.7). O afastamento de relações afetivas, comunitárias ou profissionais aumenta a dependência da vítima e eleva o risco de agravamento da violência, especialmente quando associado a controle coercitivo, ciúmes e monitoramento. Diante de resposta positiva, recomenda-se atenção às possibilidades de reconexão com redes comunitárias e o acompanhamento psicossocial para resgate da autonomia e autoestima.

18. Você possui alguma deficiência ou doença degenerativa que acarreta condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental?

Esta pergunta identifica condições de saúde e deficiência que podem aumentar a vulnerabilidade da vítima à violência (Seções 2.3 e 3.6), reduzindo sua capacidade de defesa, mobilidade ou solicitação de ajuda. A dependência de cuidados ou suporte do(a) agressor(a) pode intensificar o controle coercitivo e dificultar a ruptura da violência, exigindo atenção prioritária para estratégias de proteção e acionamento de serviços especializados de apoio e acessibilidade.

19. Com qual cor/raça você se identifica?

A cor/raça não é um fator de risco direto para a violência, porém, em razão do racismo estrutural e das desigualdades históricas, mulheres negras (pretas e pardas) e

indígenas encontram-se, de maneira desproporcional, em situações de maior vulnerabilidade econômica, social e territorial, o que aumenta a exposição ao risco e dificulta o acesso à proteção e à rede de atendimento (Seções 2.1, 2.3 e 3.6). O racismo também pode reduzir a autoestima da mulher, facilitando o abuso pelo(a) ofensor(a) da dependência emocional da vítima e dificultando o término de uma relação em curso. No caso de relações já findas, o racismo exacerba o sentimento de desprezo e normaliza violências contra corpos representados como "violentáveis". Portanto, essa informação é essencial para qualificar a análise interseccional do risco e orientar políticas de proteção mais adequadas, como encaminhamento para atendimento psicossocial, programas de geração de renda e empregabilidade, auxílio-aluguel, demais benefícios assistenciais etc.



BLOCO IV – OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
20. Você considera que mora em bairro, comunidade, área rural, território indígena ou outro local de maior risco de violência?

Esta pergunta permite identificar vulnerabilidades territoriais, que não constituem fator de risco direto, mas podem ampliar a exposição à violência e dificultar o acesso à rede (Seção 3.6). Mulheres que vivem em áreas rurais, comunidades periféricas, territórios indígenas ou regiões com conflito fundiário tendem a encontrar maiores barreiras de segurança, mobilidade e atendimento, tornando a avaliação de risco mais complexa e demandando estratégias de resposta adaptadas ao contexto territorial. Muitas vezes, essas mulheres têm mais dificuldades de romper uma relação afetiva abusiva por necessitarem da presença de um homem na casa, para evitar outras formas de violência comunitária.



21. Qual a sua situação de moradia?
22. Atualmente, você reside no mesmo imóvel com o(a) agressor(a)?

Essas perguntas integram a análise das condições habitacionais e da proximidade física com o(a) agressor(a), fatores diretamente relacionados à possibilidade de fuga, proteção e autonomia da vítima. A moradia cedida, de favor ou compartilhada com familiares do(a) agressor(a) – ou quando há dependência econômica dele(a) na moradia alugada – tende a intensificar o controle coercitivo e a dificultar a ruptura do relacionamento. Quando a vítima reside no mesmo imóvel com o(a) agressor(a), há acesso constante e maior probabilidade de repetição e agravamento da violência, exigindo estratégias urgentes de proteção, como o afastamento do(a) agressor(a) do lar e proibição de contato com a vítima. Também pode ser avaliado, com consentimento informado da mulher, o seu afastamento territorial seguro, por exemplo, com encaminhamento a casa-

abrigo ou mudança protegida para outro município ou residência de familiares/amizades. Destaca-se, ainda, a concessão de auxílio-aluguel prevista no art. 23, VI, da Lei Maria da Penha, como importante estratégia de proteção nesses casos.



23. Você se considera financeiramente dependente do(a) agressor(a)?

Esta pergunta identifica dependência econômica, um dos principais fatores que dificultam a ruptura da violência e aumentam a vulnerabilidade social e material da vítima (Seção 3.7). Quando a mulher depende financeiramente do(a) agressor(a) – parcial ou totalmente –, ela pode enfrentar barreiras para sair do relacionamento, acessar serviços e garantir a própria subsistência e de seus(suas) dependentes, o que amplifica o controle coercitivo e demanda estratégias de proteção que incluam encaminhamentos socioassistenciais, acesso a direitos e fortalecimento de sua autonomia. Mesmo quando a mulher trabalha, a usual diferença de renda entre homens e mulheres faz com que as mulheres necessitem da complementação de renda do parceiro, prendendo-a numa relação abusiva. A aplicação de medidas protetivas como prestação de alimentos provisionais ou provisórios pelo(a) agressor(a) (art. 22, V, Lei Maria da Penha), ou concessão de auxílio-aluguel (art. 23, VI, LMP), também são muito importantes.



24. Você quer e aceita abrigamento temporário?

Essa pergunta não trata de um fator de risco, mas uma necessidade de proteção da mulher. O abrigamento é uma medida emergencial de proteção utilizada quando há risco grave ou iminente à vida da mulher e de seus(suas) dependentes. Trata-se de um local seguro e sigiloso, com acompanhamento psicossocial, destinado a interromper a situação de violência e garantir proteção integral. A mulher pode ser acolhida sozinha ou acompanhada de seus filhos menores – em geral, filhos menores de 12 anos e filhas menores de 18 anos, além de outros familiares dependentes, como pais idosos, conforme diretrizes internas de cada abrigo e disponibilidade de vagas. Por razões de segurança, esses serviços adotam regras específicas, como sigilo do endereço, restrições de visitas, controle do uso de celular, bem como normas de convivência durante a permanência. Mais informações podem ser consultadas nas *Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e de Violência* (Brasil, 2011b).